Boletín Epidemiológico N° 28 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

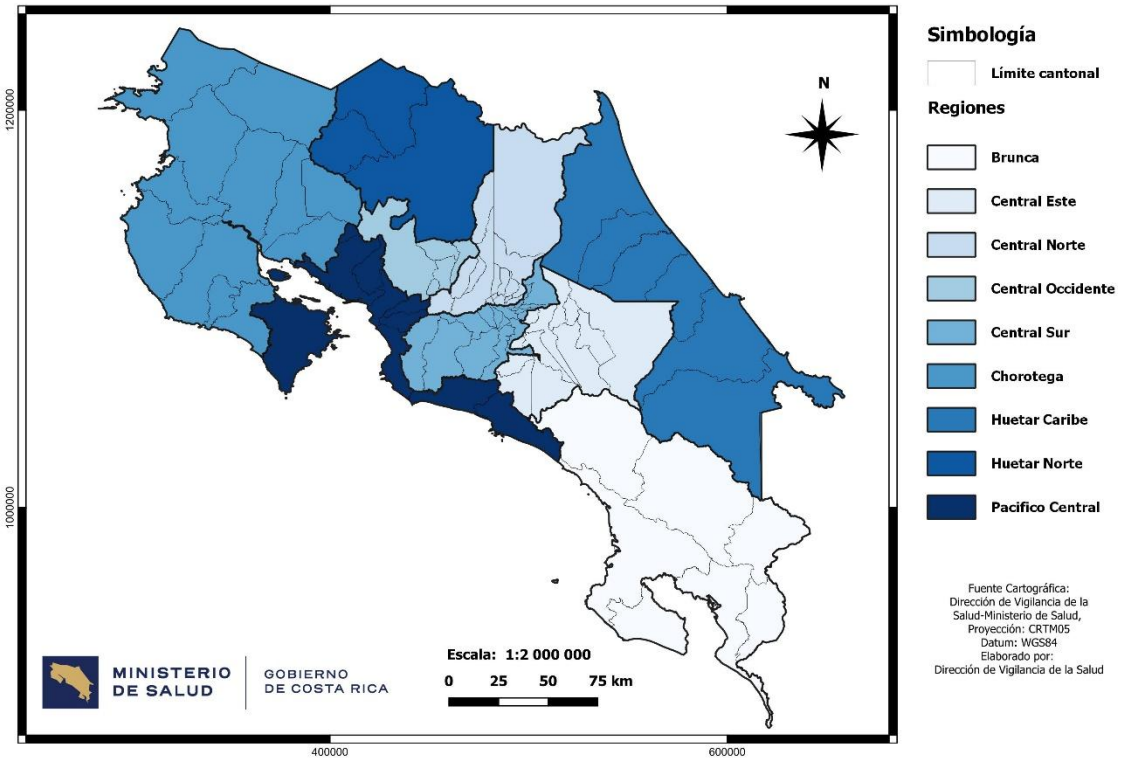
Ministerio de Salud

1 de agosto de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 29 . 8
Malaria 10
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 18
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 34
Meningitis 38
Infecciones de transmisión sexual 42
Miasis por gusano barrenador en humanos 55

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

A la semana epidemiológica 29 del año 2025 se notifican **2594 casos** de dengue, de estos 27 acumulados notificados con signos de alarma.

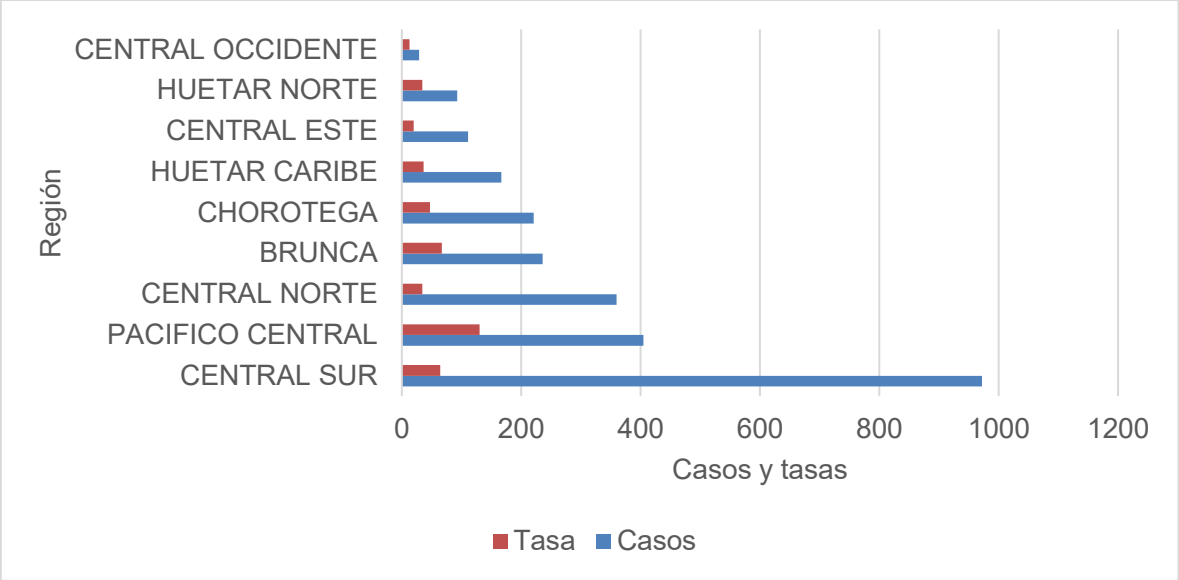
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 972 casos y la tasa más alta en la Pacífico Central 130,1/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 29, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	972	64,4
Pacifico Central	405	130,1
Central Norte	360	34,4
Brunca	236	66,8
Chorotega	221	46,9
Huetar Caribe	167	36,6
Central Este	111	20,1
Huetar Norte	93	34,6
Central Occidente	29	13,0
Total	2594	50,0

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 29, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

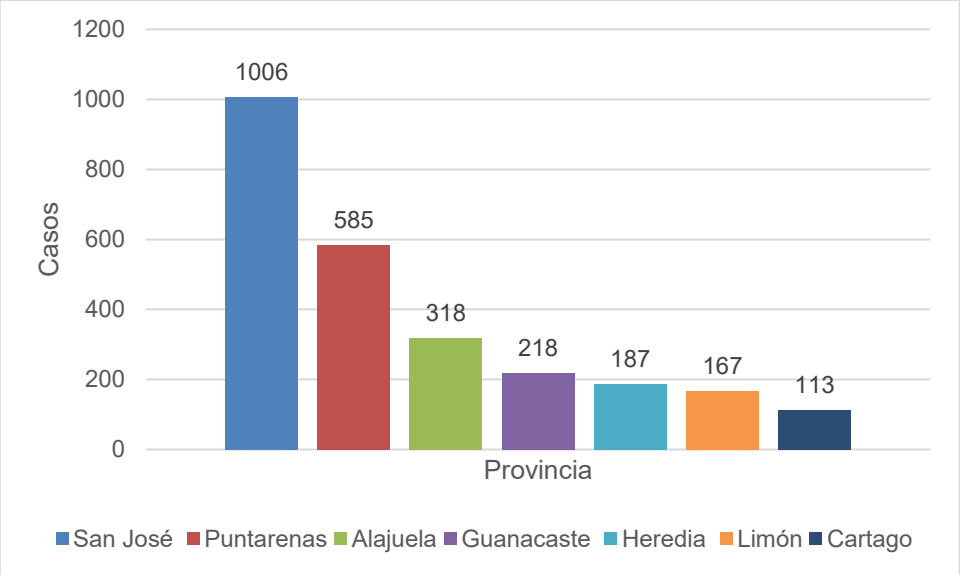
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2025.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	1006	60,5	507	60,1	499	60,9
Puntarenas	585	115,7	271	108,4	314	122,8
Alajuela	318	29,6	166	31,0	152	28,2
Guanacaste	218	52,7	96	46,8	122	58,5
Heredia	187	34,2	88	32,1	99	36,4
Limón	167	36,6	71	31,9	96	41,2
Cartago	113	21,2	46	17,2	67	25,3
Total	**2594**	**50,0**	**1245**	**47,9**	**1349**	**52,0**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 29, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 29 son: San José 591 casos, Alajuela 148 casos, Puntarenas 145 casos, Esparza 128 casos, y Sarapiquí 105 casos.

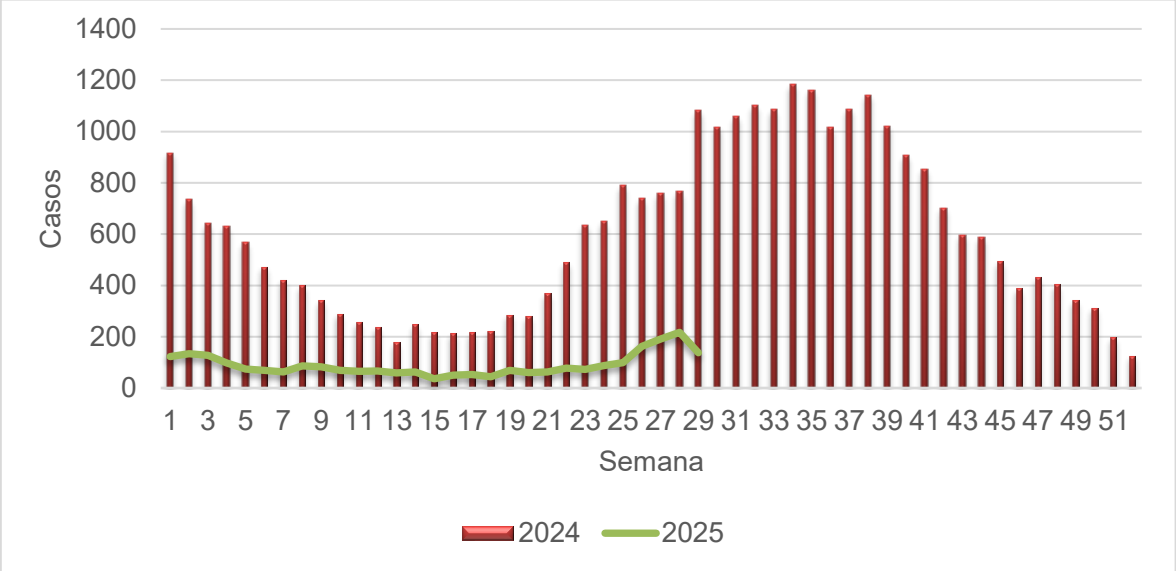
Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 29, 2025.

Cantón	Casos	Tasa
101: San José	591	167,3
201: Alajuela	148	45,1
601: Puntarenas	145	100,4
602: Esparza	128	360,5
410: Sarapiquí	105	108,8
110: Alajuelita	91	93,4
610: Corredores	84	157,4
103: Desamparados	72	29,4
210: San Carlos	64	30,2
605: Osa	61	207,0
702: Pococí	54	34,6
109: Santa Ana	51	82,1

609: Parrita	49	217,4
502: Nicoya	42	71,2
401: Heredia	40	27,3
305: Turrialba	38	55,3
119: Pérez Zeledón	36	27,0
604: Montes de Oro	36	240,6
607: Golfito	35	109,4
701: Limón	34	36,9

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Figura 3.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 29, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

A la semana epidemiológica 29 del 2024 se reportó un total de 14046 casos de dengue, para este 2025 se reportan 2594 para un descenso del 81,5% con respecto a la misma semana epidemiológica.

Tabla 4.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 29, 2024-2025.

Semana	2024	2025
1	917	123
2	735	134
3	641	128
4	631	97
5	568	74
6	472	69
7	421	63
8	401	86
9	340	82
10	289	69
11	256	65
12	238	66
13	178	59
14	247	62
15	216	36
16	214	50
17	216	52
18	223	44
19	285	69
20	280	60
21	368	62
22	489	77
23	636	73
24	648	88
25	790	99
26	739	162
27	758	191
28	768	217
29	1082	137
Total	**14046**	**2594**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

El área de estadística en salud de la CCSS reporta al 28 de julio 4 personas hospitalizadas por dengue: dos en el Hospital Monseñor Sanabria, uno en el Hospital de La Anexión y uno en el Hospital Nacional de Niños.

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 29

Rodrigo Marín Rodríguez
Programa de Control de Vectores
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

Rose Mary Hidalgo Ríos
Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM)

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la Semana Epidemiológica 29 del 2025, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la Semana Epidemiológica 29 del 2025.

	Total
Viviendas visitadas	**9.071**
Viviendas positivas	**487**
Depósitos tratados	**38.564**
Depósitos eliminados	**10.682**
Depósitos positivos	**702**
Viviendas fumigadas	**19.693**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Así mismo se detalla lo que llevamos de la Semana Epidemiológica 1 a la 29 del 2025

	Total
Viviendas visitadas	**356.264**
Viviendas positivas	**16.243**
Depósitos tratados	**1.322.024**
Depósitos eliminados	**921.354**
Depósitos positivos	**28.004**
Viviendas fumigadas	**344.933**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Sarah Arce Bonilla
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

Situación de la malaria en Costa Rica: actualización a la semana epidemiológica 29 del 2025

El histórico de transmisión local de malaria en Costa Rica evidencia una tendencia sostenida a la disminución de casos en los últimos tres años. Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 a 29:

- En **2023**, se notificaron **366 casos autóctonos**.
- En **2024**, se registraron **157 casos**, lo que representa una disminución del **57 %** respecto al mismo periodo del año anterior.
- En lo que va del año **2025**, se han reportado **6 casos autóctonos**, lo que representa una **reducción del 98 %** en comparación con el mismo periodo del 2023.

Esta tendencia positiva refleja el impacto de las intervenciones dirigidas a la interrupción de la transmisión local, especialmente en los focos históricos.

Distribución de casos de malaria por región de salud y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2025 (corte a la semana epidemiológica 29)

Durante el año 2025 se notificaron **36 casos de malaria** en el país. La distribución según clasificación epidemiológica y región de salud fue la siguiente:

- **6 casos autóctonos de *Plasmodium falciparum***, todos localizados en la región Huetar Caribe.
- **21 casos importados** (5 por *P. falciparum* y 16 por *P. vivax*), con mayor concentración en las regiones Huetar Norte (11 casos de *P. vivax*) y Central Sur (3 casos de *P. falciparum*). Se detectaron casos en las localidades de San Pablo (Nandayure), San Ramón (San Ramón), Corredores, Pavas (San José), Cutris (San Carlos) y Los Chiles.
- **1 caso introducido** de *P. vivax* en la región Huetar Norte.
- **8 casos en estudio** (2 por *P. falciparum* y 6 por *P. vivax*).

Las personas afectadas en 2025 se desempeñan principalmente como **operarios de construcción, peones agrícolas, coligalleros** y personas en **condición de movilidad humana**, provenientes de **Nicaragua**, de la **ruta migratoria desde América del Sur**, o en retorno desde **México** y **Gabón (África)**.
Esta información resalta la importancia de mantener la vigilancia activa, fortalecer los mecanismos de respuesta en zonas de riesgo y asegurar el diagnóstico y tratamiento oportuno, con enfoque especial en poblaciones móviles y zonas de tránsito.

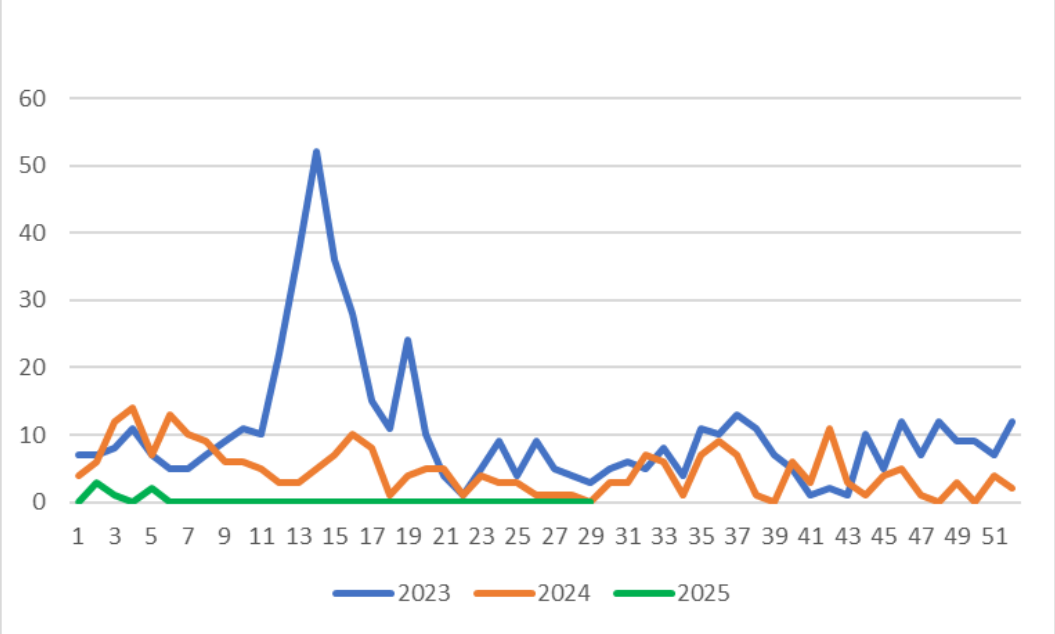
Tabla 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE26.

Histórico Transmisión local			
Semana Epidemiológica	2023	2024	2025
1	7	4	0
2	7	6	3
3	8	12	1
4	11	14	0
5	7	7	2
6	5	13	0
7	5	10	0
8	7	9	0
9	9	6	0
10	11	6	0
11	10	5	0
12	22	3	0
13	37	3	0
14	52	5	0
15	36	5	0
16	28	7	0
17	15	8	0
18	11	1	0
19	24	4	0
20	10	5	0
21	4	5	0
22	1	1	0

23	5	4	0
24	9	3	0
25	4	3	0
26	9	1	0
27	5	1	0
28	4	1	0
29	3	0	0
Total	**366**	**157**	**6**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 29.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Producción de pruebas de diagnóstico

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.

A semana epidemiológica 29, se registraron 74.479 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por el Ministerio de Salud**: 35.075 referirse a la tabla 2.
    - **Colaboradores Voluntarios**: 791
    - **Inspectores de Salud**: 34.284

- **Pruebas de diagnóstico realizadas por CCSS**: 39.404, referirse al gráfico 3.
    - **Gotas gruesas**: 7.131
    - **Pruebas de diagnóstico rápido**: 31,916
    - **PCR**: 357

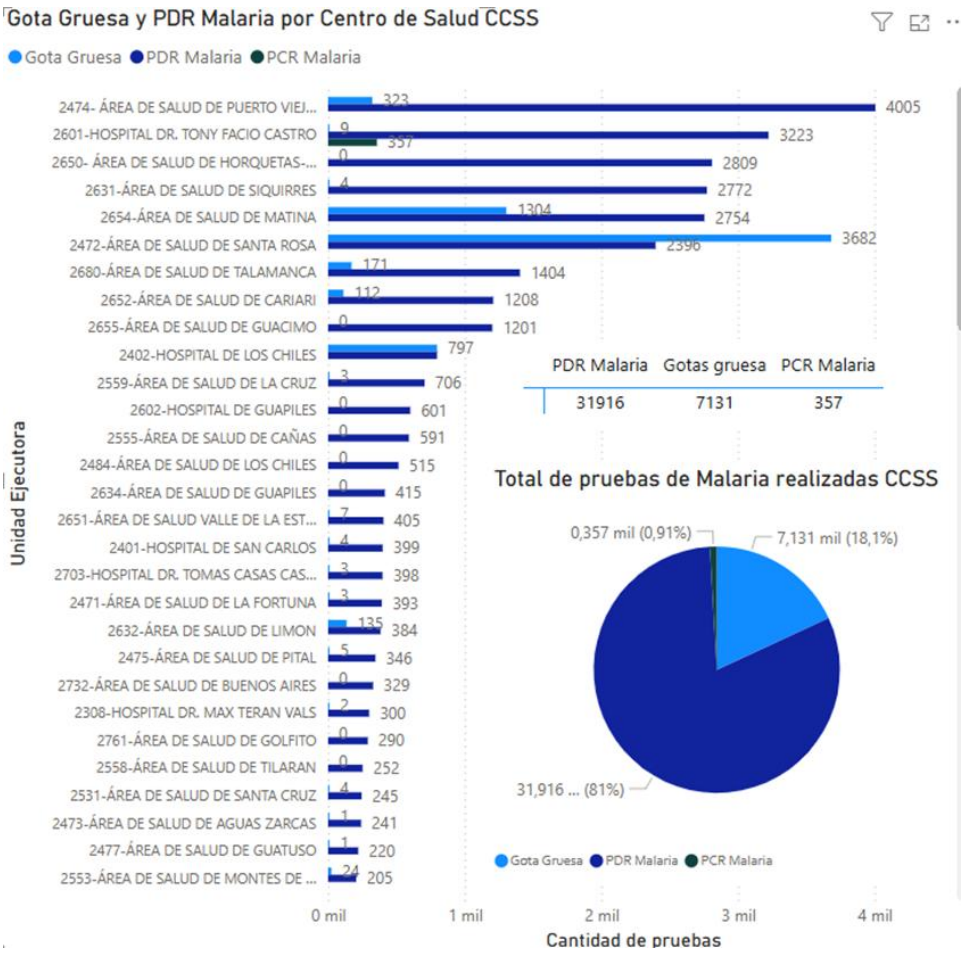
Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.
Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para cuantificar la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva.

Tabla 2.
Costa Rica: Vigilancia generada por inspectores de salud y voluntarios

Región	Pruebas realizadas por Inspectores de Salud	Pruebas realizadas por voluntarios
Brunca	11849	53
Central Norte	168	28
Chorotega	4628	137
Huetar Caribe	7972	227
Huetar Norte	8024	309
Pacífico Central	1497	37
Total	34284	791

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 3.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS



Fuente: CCSS.

Tabla 2.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS por región.

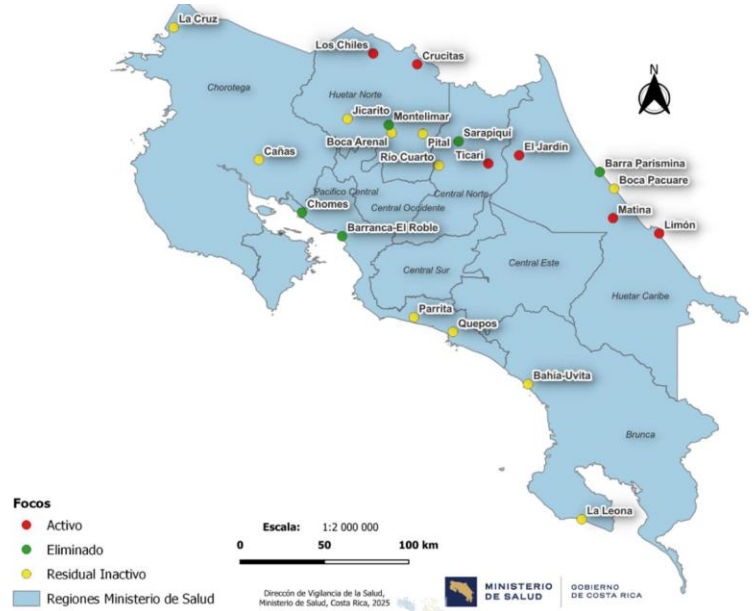
Dirección Regional a la que pertenece	Gotas Gruesas	PDR Malaria	PCR Malaria
Región Huetar Atlántica	1742	14369	357
Región Central Norte	354	6842	
Región Huetar Norte	4493	5471	
Región Chorotega	89	2246	
Región Brunca	33	1687	
Región Pacífico Central	171	1072	
Hospitales Nacionales o Especializados	217	206	
Región Central Sur	32	23	
Total	**7131**	**31916**	**357**

Fuente: CCSS.

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 6 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a mayo 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Ric

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Listado de Focos de malaria a Enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

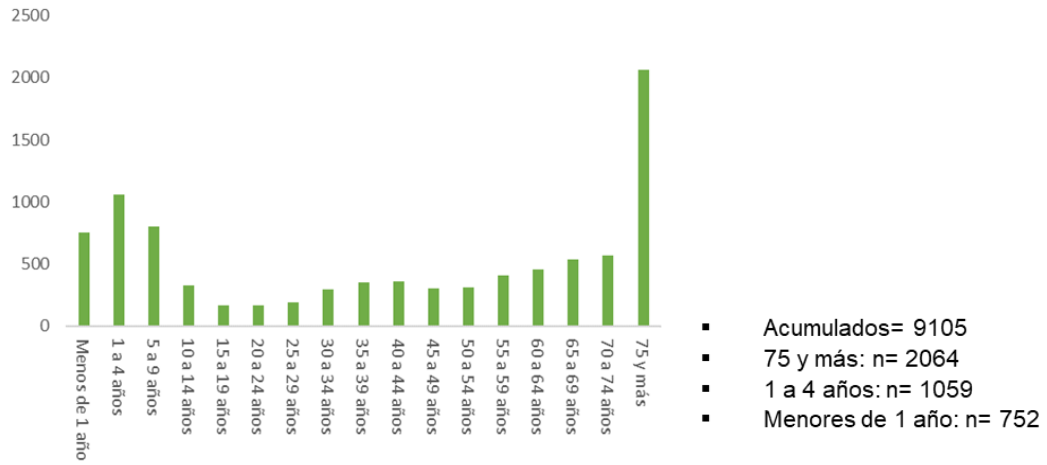
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 29 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 28 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 29 son un total de 9105.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

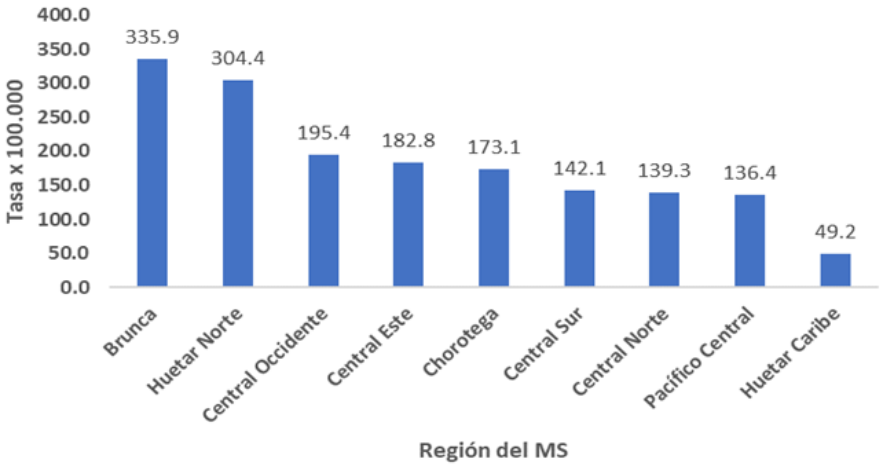
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 29, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 29, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Brunca y la Huetar Norte; las regiones con menor incidencia corresponden a la Chorotega, Central Este, Central Occidente, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.

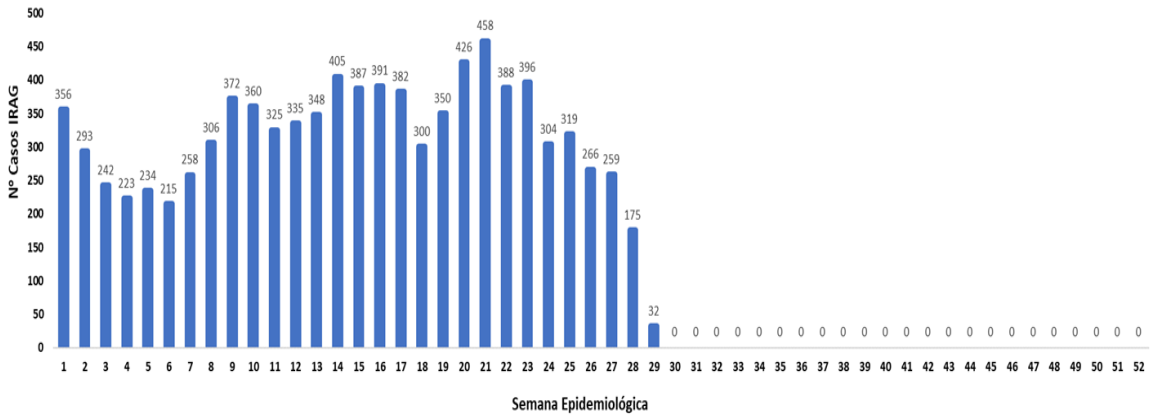
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 29 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 29 del año 2025.

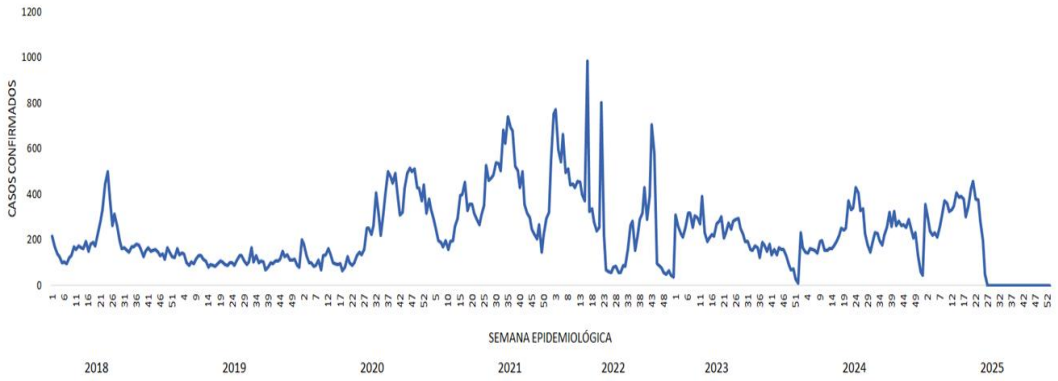
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 29, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

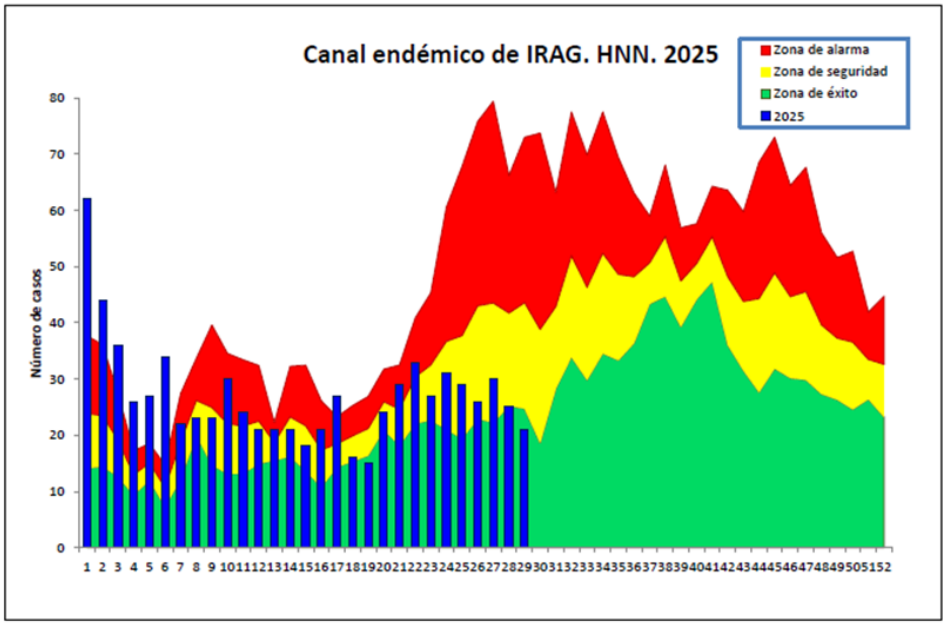
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-29 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra por en zona de éxito, debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2025

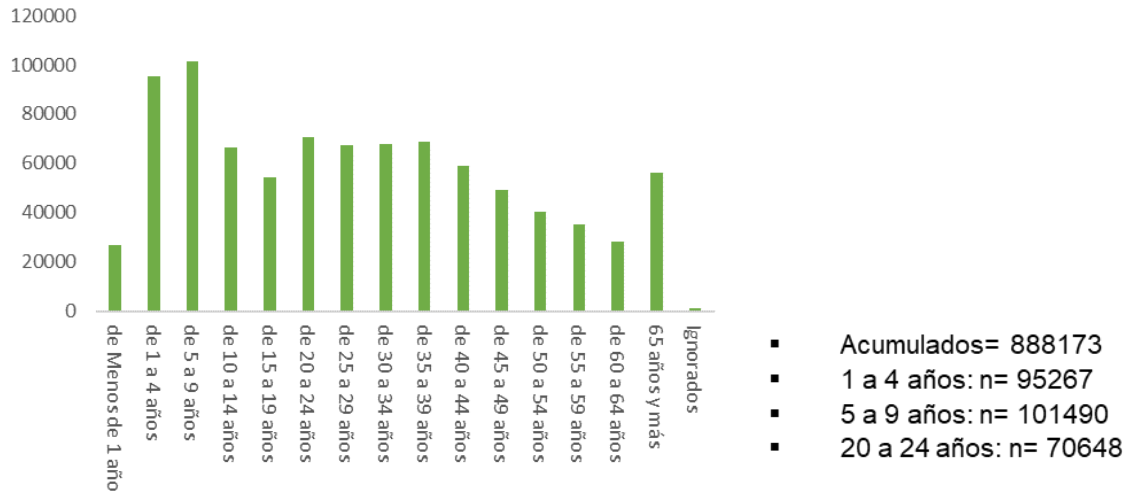


Fuente: EDUS-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 28 son 888173.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y menores entre 5 y 9 años.

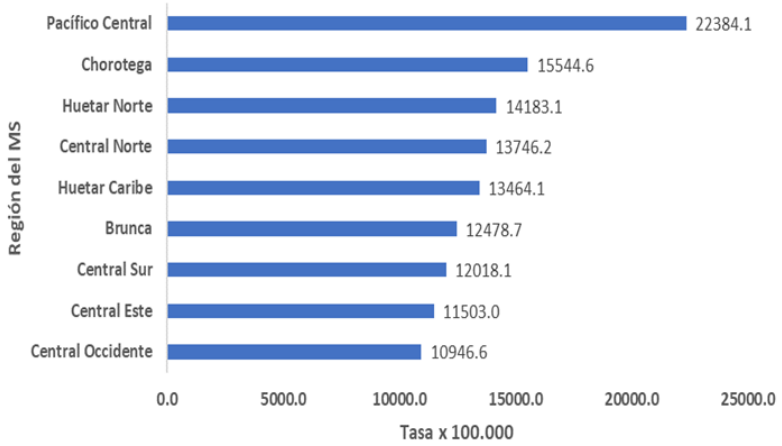
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 28, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 28, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central, Chorotega y Huetar Norte. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Central Norte, Huetar Caribe, Brunca, Central Occidente, Central Sur y Central Este.

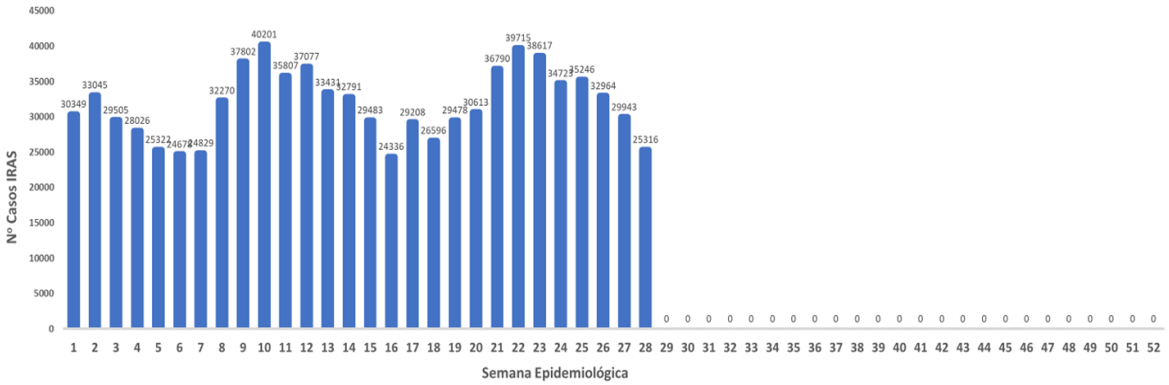
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 28 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 28 semanas epidemiológicas del año 2025.

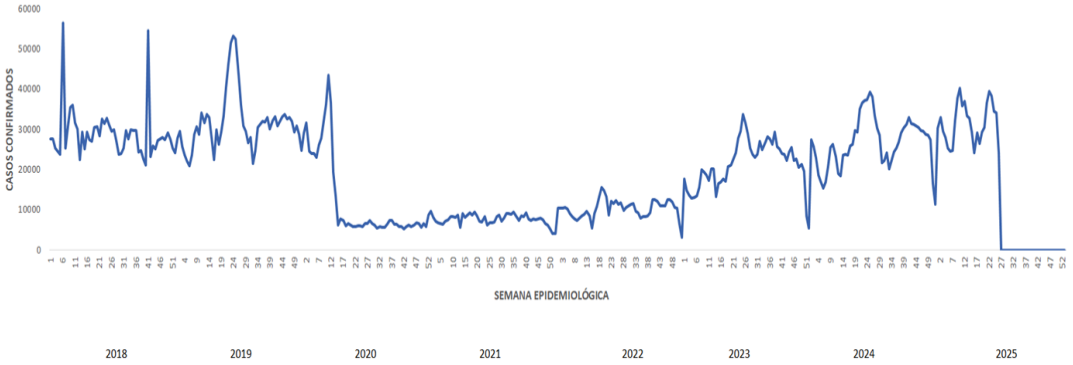
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 28, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

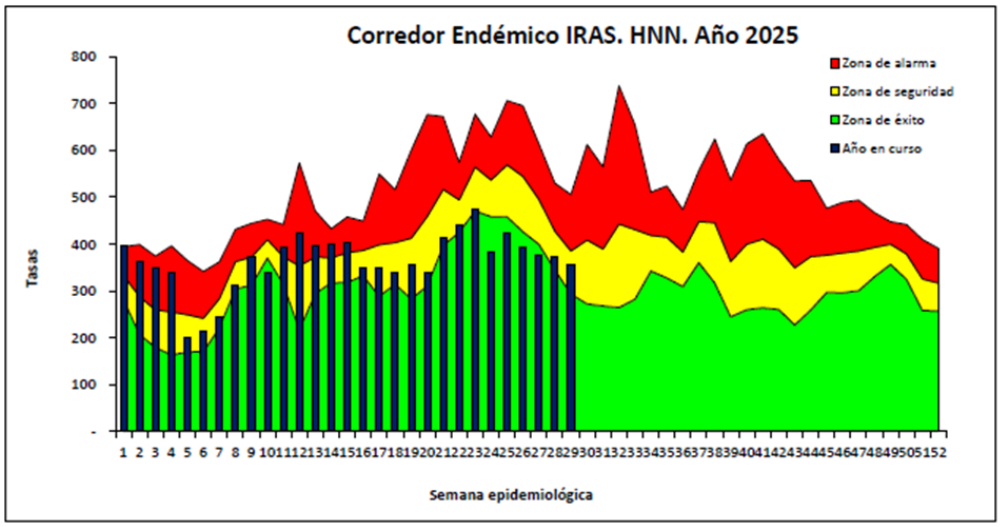
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 29 se encuentran en la zona de seguridad actualmente.

Gráfico 10.
Canal endémico IRAS. HNN. 2025.

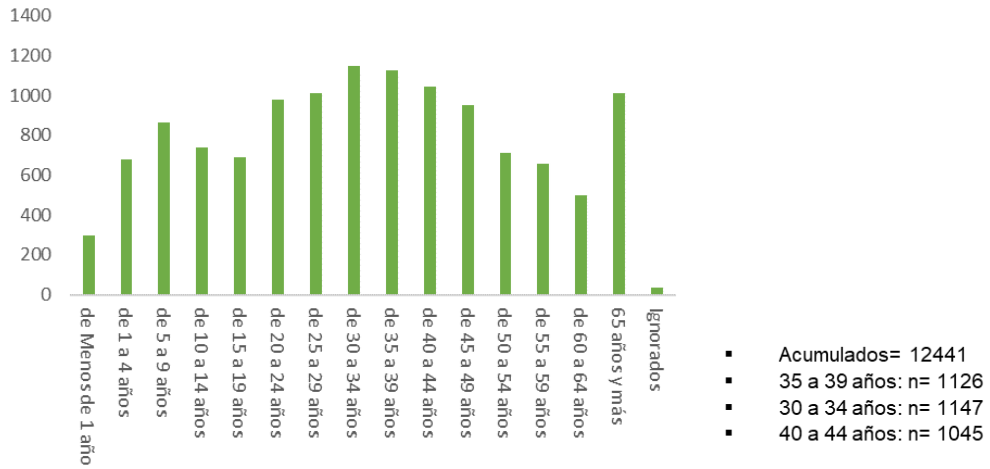


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 28 son n= 12441.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.

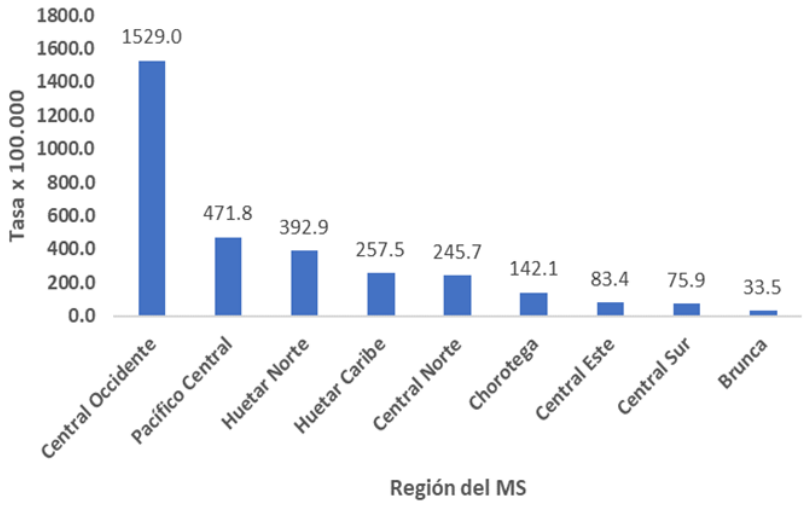
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 28, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 28, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte y Huetar Caribe.

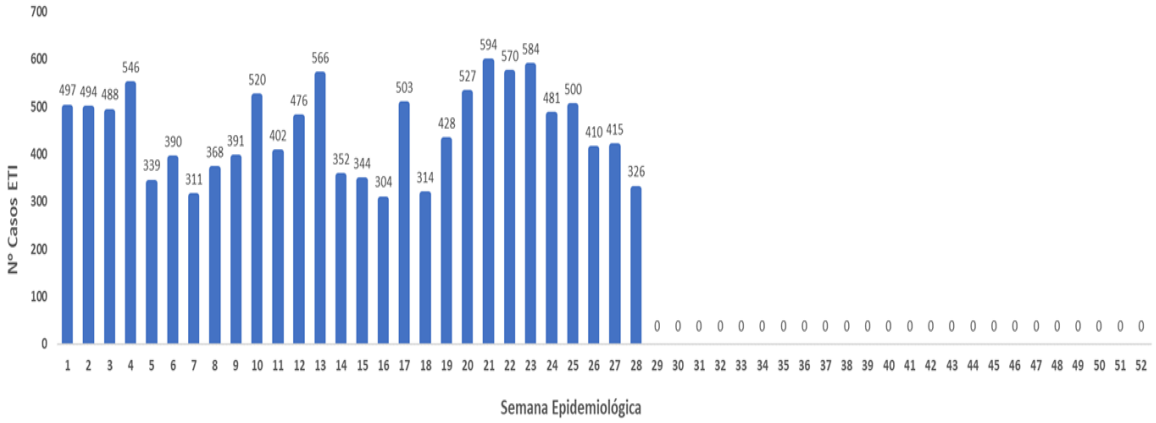
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 28 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2025.

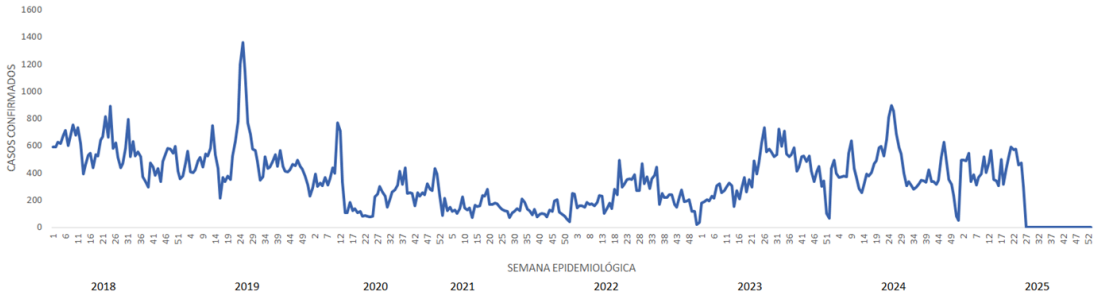
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 28, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

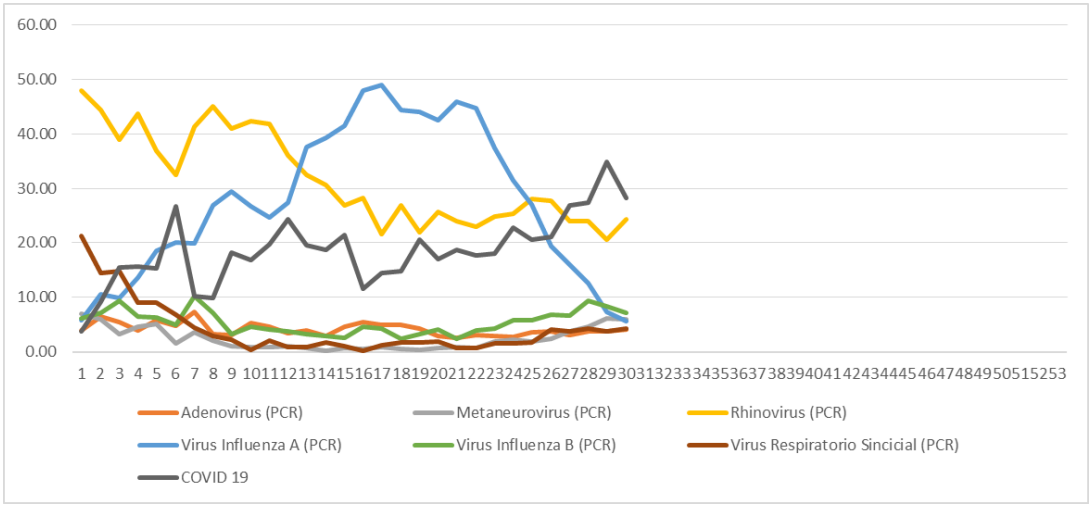
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 30; para la SE-30, en el país el Covid-19 es el que más está circulando, seguido del Rinovirus y finalmente el virus de la Parainfluenza está en tercer lugar de circulación.

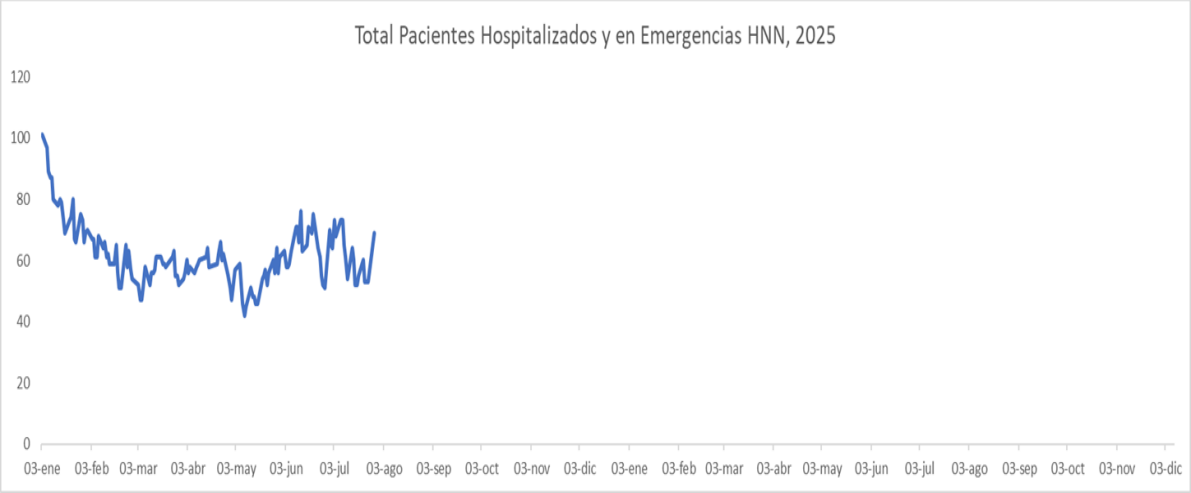
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 30 en Costa Rica, 2025.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2025.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 30 del año 2025 es la siguiente:
Al 29 de julio del año en curso, correspondiente a la semana 30, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 66, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 98.5%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 28 del año 2025, Hospital Nacional de Niños.



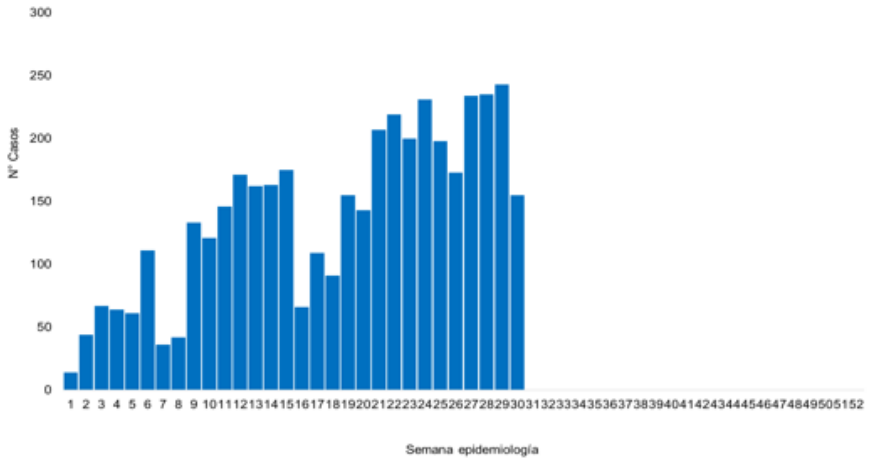
Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2025.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 9105 casos a la semana 29.
- IRAS con 888173 casos a la semana 28.
- ETI con 12441 casos reportados a la semana 28.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 98.5%
- En SE-30, el Covid-19 es el virus que más ha circulado, seguido del Rinovirus Covid-19 y en tercer lugar circula el Virus de Parainfluenza.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 30, se reportaron un total de 155 casos confirmados, lo que representa una disminución del 36.2% con respecto a la SE-29 del año 2025 que presentó 243 casos.

Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2025.

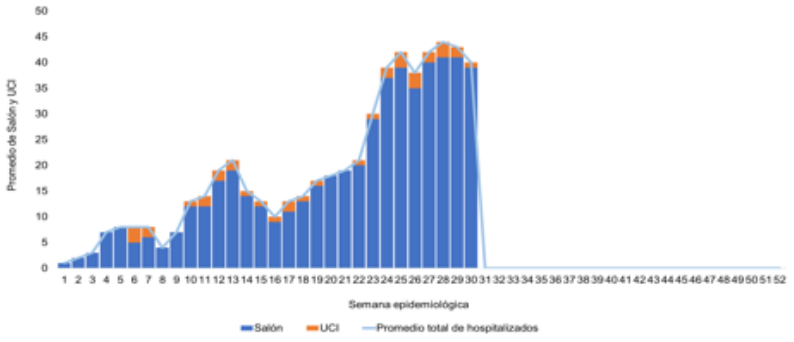


SE	Casos
1	14
2	44
3	67
4	64
5	61
6	111
7	36
8	42
9	133
10	121
11	146
12	171
13	162
14	163
15	175
16	66
17	109
18	91
19	155
20	143
21	207
22	213
23	200
24	231
25	198
26	173
27	234
28	235
29	243
30	155

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 30, se reportó un promedio total de 40 hospitalizados, lo que representa una disminución del 6.9% con respecto a la SE-29 del año 2025 donde se registraron 43 hospitalizaciones.

Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2025.

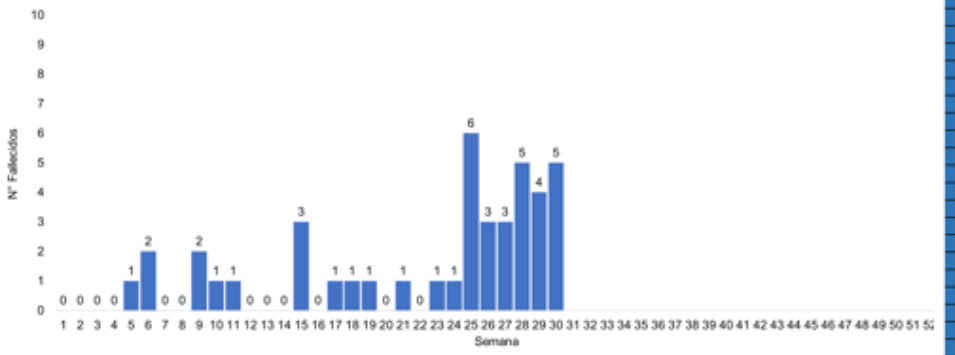


SE	Salón	UCI	Promedio total de
1	1	0	1
2	2	0	2
3	3	0	3
4	7	0	7
5	8	0	8
6	5	3	8
7	6	2	8
8	4	0	4
9	7	0	7
10	12	1	13
11	12	2	14
12	17	2	19
13	19	2	21
14	14	1	15
15	12	1	13
16	9	1	10
17	11	2	13
18	13	1	14
19	16	1	17
20	18	0	18
21	19	0	19
22	20	1	21
23	29	1	30
24	37	2	39
25	39	3	42
26	35	3	38
27	40	2	42
28	41	3	44
29	41	2	43
30	39	1	40

Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 30, hubo 5 fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2025.

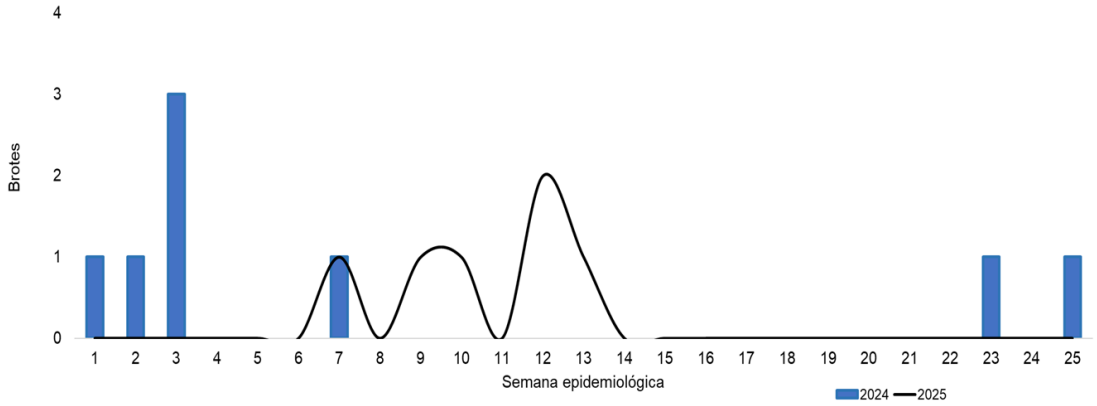


Semanas	Fallecidos
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1
6	2
7	0
8	0
9	2
10	1
11	1
12	0
13	0
14	0
15	3
16	0
17	1
18	1
19	1
20	0
21	1
22	0
23	1
24	1
25	6
26	3
27	3
28	5
29	4
30	5

Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

Para la semana epidemiológica 29 no se reportó ningún brote asociado a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2025.



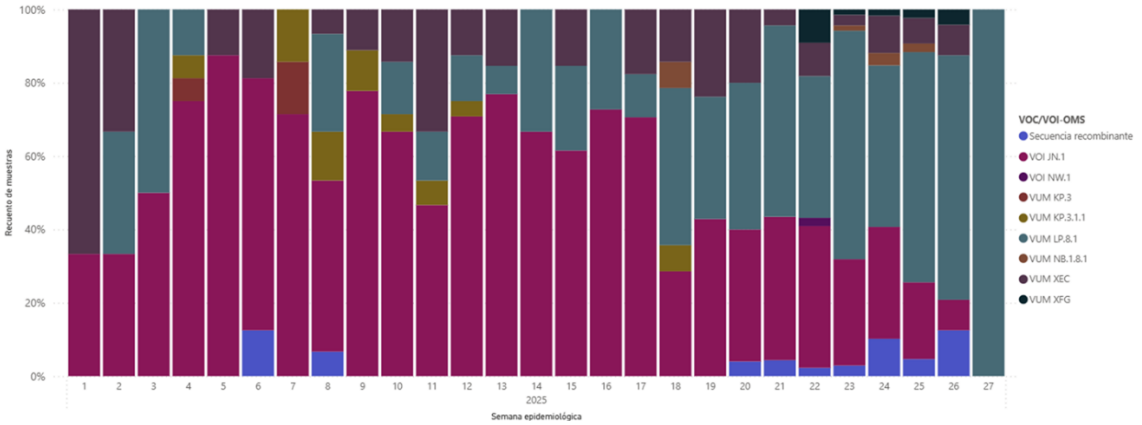
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Nota: Se reportaron 24 brotes en el año 2024 y se han reportado 6 brotes en el año 2025

Variantes genómicas

Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 29 de julio del 2025, se reporta lo siguiente.

Gráfico 21.
Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1-27 del 2025.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 29 de julio del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre la SE-1 y la 27 del año 2025, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1.
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo de las semanas epidemiológicas 1-27 del 2025.

Linaje Pangolin	Cantidad	%
Secuencia recombinante	19	3.54
VOI JN.1	239	44.59
VOI NW.1	1	0.19
VUM KP.3	2	0.37
VUM KP.3.1.1	10	1.87
VUM LP.8.1	194	36.19
VUM NB.1.8.1	5	0.93
VUM XEC	58	10.82
VUM XFG	8	1.49
Total	536	98.51

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 29 de julio 2025.

Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 28 de julio 2025.

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la semana epidemiológica 29 del año 2025 se reportan 241,433 casos acumulados de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). De acuerdo con el comportamiento epidemiológico de este evento, se observa una curva epidémica ubicada en zona de seguridad, con una tasa de incidencia de 4,650 casos por cada 100,000 habitantes, calculada con base en la actualización de datos poblacionales estimados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

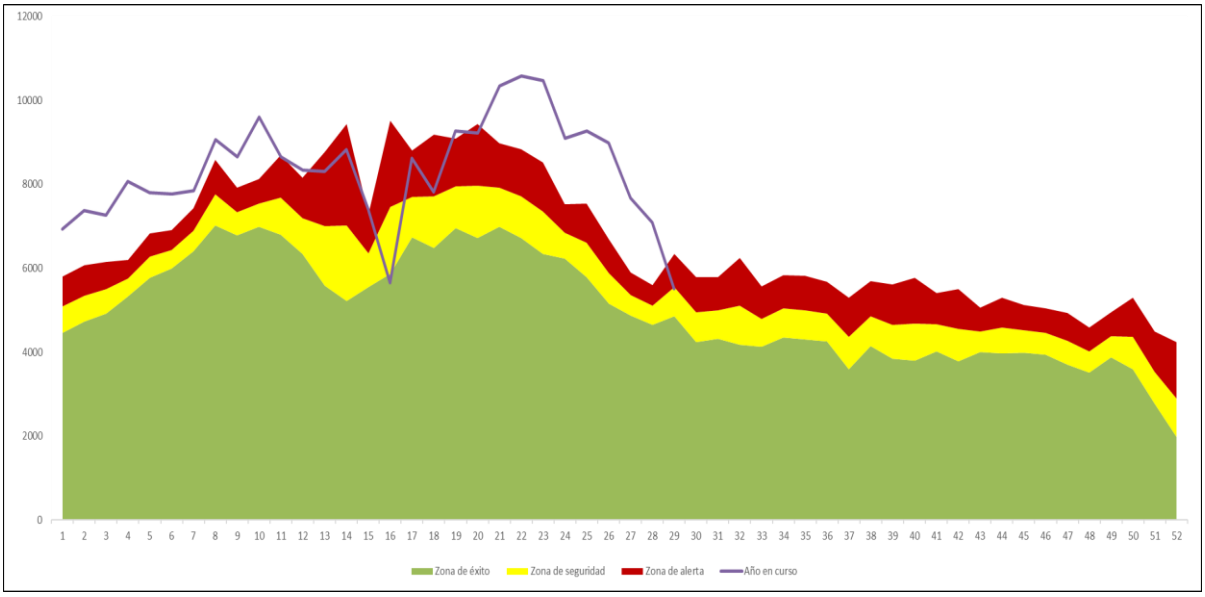
La incidencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) para la Semana Epidemiológica (SE) 29 del año 2025 refleja una disminución en los casos notificados respecto al mismo periodo del año 2023, pasando de 7,029 a 5,503 casos. Esta reducción marca el cierre del segundo trimestre bajo una tendencia descendente sostenida a partir de la SE 20, comportamiento que contrasta con el aumento registrado en la misma etapa del 2023.

Durante las primeras 15 semanas del 2025, se observó una tendencia al alza respecto al 2023, con valores significativamente superiores, particularmente entre la SE 8 y SE 14, donde se alcanzaron picos como los 9,603 casos en la SE 10 (vs 6,602 en 2023). No obstante, a partir de la SE 16, esta tendencia comienza a revertirse progresivamente, y para la SE 29 se consolida una predisposición disminuida en la frecuencia de casos.

Este patrón refleja una situación epidémica ubicada en zona de alerta del canal endémico, lo cual coincide con la presencia del fenómeno climático de La Niña, asociado históricamente con un incremento en las lluvias y la humedad, condiciones que pueden favorecer la transmisión de agentes causantes de diarreas. Cabe destacar que en el 2023 se presentó una situación epidemiológica similar también bajo los efectos de La Niña.

En general, a pesar de que los primeros meses del 2025 mostraron una mayor carga de casos acumulados que el año de referencia (2023), las semanas más recientes apuntan a una disminución progresiva, lo cual sugiere una evolución controlada del evento. No obstante, los datos presentados son preliminares y se encuentran en proceso de validación, por lo que podrían surgir ajustes que modifiquen la posición actual en el canal endémico.

Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 29. Años 2017- 2025. *



*Nota: Se excluyen del 2020 y 2021por la pandemia COVID-19 y 2023 por hackeo de la CCSS.
Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

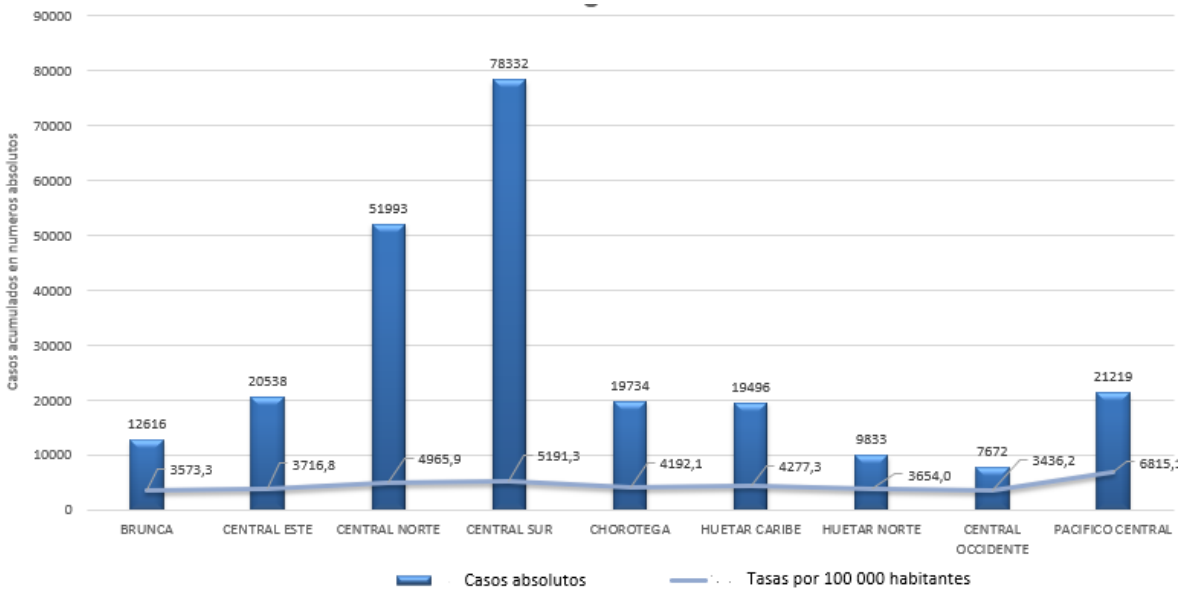
El canal endémico para EDA muestra el comportamiento esperado de los casos en función de los datos históricos, clasificado en zonas de éxito (verde), seguridad (amarillo), alerta (rojo) y la línea morada correspondiente al año 2025.
Durante las primeras semanas epidemiológicas (SE 1–7), los casos se mantuvieron ligeramente por encima de la zona de éxito, oscilando entre la zona de seguridad y los límites inferiores de la zona de alerta. A partir de la SE 8, se presenta un ascenso más marcado, con inclusión constante dentro de la zona de alerta entre las semanas 8 y 14, superando incluso los picos máximos del canal histórico en semanas puntuales como la SE 10 y 13.
El punto más alto del año ocurre alrededor de la SE 14 a 15, seguido de una caída abrupta, pero que no logra sostenerse por debajo de la zona de alerta. Desde la SE 16 hasta la SE 23, los casos se estabilizan dentro o cerca del límite superior de la zona de alerta, reflejando un periodo de persistencia epidémica sostenida. En la SE 24 en adelante, se observa una disminución progresiva con oscilaciones hacia la zona de seguridad y posteriormente hacia la zona de éxito a partir de la SE 27–29, lo que indica un descenso epidemiológico favorable.

Este patrón sugiere que el país atravesó un evento epidémico leve a moderado durante el segundo trimestre, probablemente influenciado por factores climáticos (como el fenómeno de La Niña), condiciones ambientales propicias para la transmisión y posiblemente mayor susceptibilidad poblacional. No obstante, la tendencia descendente observada en las últimas semanas sugiere que las medidas de control podrían estar teniendo efecto, aunque aún se debe mantener vigilancia activa, especialmente si se mantienen condiciones lluviosas o de riesgo sanitario.

A la Semana Epidemiológica 29 del 2025, los 15 cantones con las tasas de incidencia más elevadas de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) son: Flores, Vázquez de Coronado, Orotina, Puntarenas, Santa Cruz, Montes de Oro, Garabito, Matina, San Rafael, Mora, Goicoechea, Alajuelita, Alajuela y Nandayure. Estos cantones presentan una incidencia significativamente superior al promedio nacional, destacándose por mantener tasas elevadas de manera sostenida a lo largo del primer semestre del año, lo que sugiere una persistencia del riesgo epidemiológico en estos territorios, o una mejor notificación de estos eventos en los servicios de salud.

Las Regiones Rectoras con más casos son: Pacifico Central, Central Norte, Central Sur. El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según región del Ministerio de Salud. SE 29, 2025.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Al analizar los casos acumulados y las tasas por 100,000 habitantes de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) a la semana epidemiológica 29 del 2025, se evidencia una distribución heterogénea entre las distintas regiones de salud del país. La región Central Sur registra la mayor carga absoluta con 78,332 casos, seguida por la Central Norte con 51,993 casos. No obstante, la tasa más alta se presenta en la región Pacífico Central con 6,815.4 casos por cada 100,000 habitantes, lo que indica una afectación proporcionalmente más alta respecto a su población. Las regiones Chorotega y Huetar Caribe mantienen una carga moderada, con tasas que superan los 4,000 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que Brunca y Central Este reportan incidencias más bajas. Por su parte, la región Huetar Norte muestra la menor cantidad de casos notificados (9,833), con una tasa de 3,654.0, y la región Central Occidente se mantiene como la menos afectada en términos relativos y absolutos. Este comportamiento regional resalta la necesidad de enfocar acciones de prevención y control en las zonas con mayor incidencia relativa y carga acumulada, particularmente en las regiones Central Sur, Central Norte y Pacífico Central.

Se recomienda reforzar las campañas de educación dirigidas a la población, enfatizando el cumplimiento del protocolo de lavado de manos, así como la promoción de adecuadas prácticas de higiene personal, manipulación segura de alimentos y correcta cocción de estos. Estas medidas resultan fundamentales ante el incremento sostenido en los casos de diarrea aguda reportados por el sistema de salud, tanto de origen viral como bacteriano, los cuales superan el comportamiento esperado para esta época del año.

En este contexto, cobra especial relevancia la aplicación rigurosa del Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, el cual orienta las acciones necesarias para la investigación oportuna de los casos y brotes, incluyendo el uso de flujogramas para abordar distintas etiologías probables. Retomar con prioridad las actividades de vigilancia activa, investigación de campo y respuesta inmediata ante alertas locales es clave para contener la transmisión, identificar factores de riesgo y reducir la carga de enfermedad en las comunidades más afectadas.

Situación de brotes

Actualmente al 28 de julio del 2025 a las 3:00pm no se mantienen alertas de brotes activos notificadas a la DVS.

Meningitis

Franchina Murillo Picado
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Paola Pérez Espinoza
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

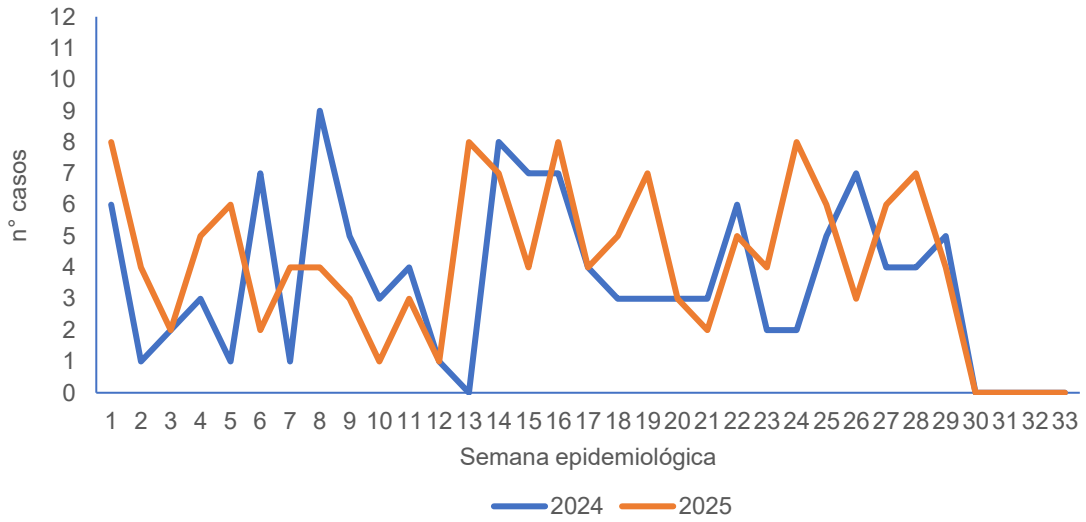
La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.

La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.

En Costa Rica, hasta la semana epidemiológica 29 del año 2025, se han registrado 134 casos sospechosos de meningitis reportados mediante boleta VE01, lo que representa una tasa de incidencia de 2,5 por cada 100.000 habitantes. En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 116 casos, se observa un incremento del 15,52% sin que se reporten brotes para esta semana.

De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la Región Central Sur es la que tiene la mayor cantidad de casos con un 23,9% (32/134) seguido de la Región Central Este con un 23,1% (31/134) y la Central Norte con el 22,4% (30/134).

Figura 1.
Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2024 con el 2025 a la semana epidemiológica 29, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

En la siguiente tabla se enlista los cantones con las tasas más altas de meningitis. Turrubares de la provincia de San José es el que tiene la tasa más alta de 13,1, seguido de Dota también de la provincia de San José con 12,2 y Cartago con 10,1.

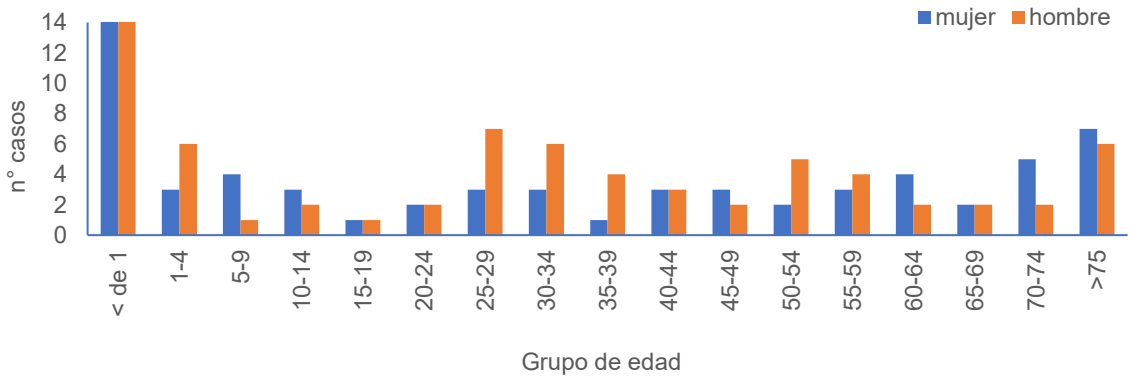
Figura 2.
Costa Rica: Casos notificados de meningitis según cantón, acumulado a la semana epidemiológica 29, 2025 (tasa p/100.000 habitantes)

cantón	casos	tasa
Turrubares	1	13,8
Dota	1	12,2
Cartago	17	10,1
Osa	3	9,5
Cañas	3	8,7
Santa Cruz	6	8,0
Bagaces	2	7,7
Sarapiqui	7	7,4
Leon Cortes	1	7,0
Alvarado	1	6,3
Jimenez	1	6,1
Liberia	5	6,0
Quepos	2	5,7
Tarrazu	1	5,2
Perez Zeledon	7	4,9
Santa Barbara	2	4,4
Valverde Vega	1	4,3
Talamanca	2	4,2
Turrialba	3	4,1
Flores	1	3,8
La Union	4	3,4
San Rafael	2	3,4
Alajuela	11	3,3
Montes de Oca	2	3,2
Moravia	2	3,1
San Pablo	1	3,1
Aserri	2	3,0
Alajuelita	3	3,0
Goicoechea	4	2,8
Esparza	1	2,5
Desamparados	6	2,4
Palmares	1	2,3
San Jose	8	2,2
El Guarco	1	2,1
Grecia	2	2,0
Naranjo	1	2,0
Barva	1	2,0
Santo Domingo	1	2,0
Limon	2	2,0
Nicoya	1	1,7
Guacimo	1	1,7
Santa Ana	1	1,6
Paraiso	1	1,5
Siquirres	1	1,5
Escazu	1	1,4
Heredia	2	1,3
Pococi	2	1,2
San Carlos	2	0,9
Total	**134**	**2,5**

Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

La figura 3, indica la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. El 47,7% de los casos (64/134) son mujeres y el 52,2% (70/134) son hombres. El 22,3% de los casos (30/134) son menores de 1 año.

Figura 3.
Costa Rica: Casos sospechosos por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 29, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son de notificación obligatoria, conforme al Reglamento de Vigilancia de la Salud N.º 40556-S. Por lo tanto, su vigilancia semanal constituye un componente esencial para la salud pública del país.

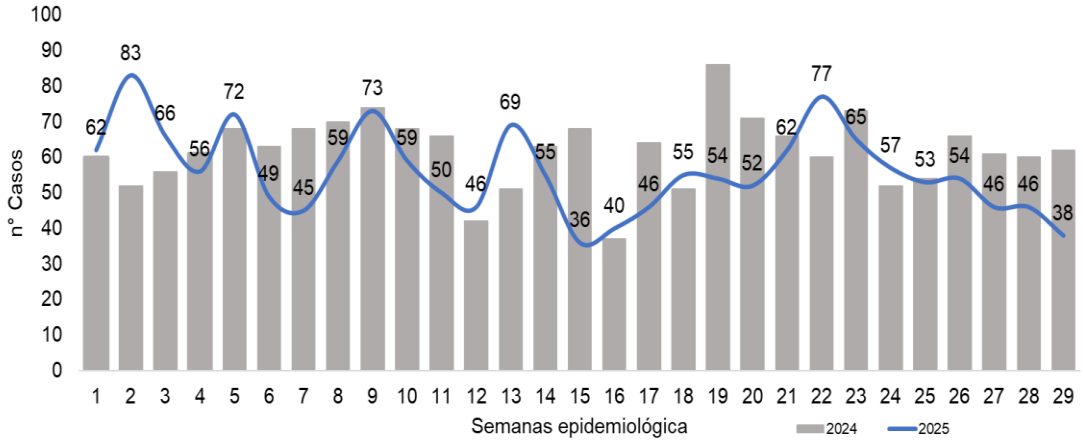
Durante las primeras 29 semanas del año 2025, se han reportado los siguientes tipos de ITS: sífilis en todas sus formas clínicas, gonorrea, infección por el virus del herpes simple (VHS) y virus del papiloma humano (VPH).

Sífilis en todas sus formas

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*, la cual es totalmente prevenible con el uso el condón y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales y de la madre al bebé durante el embarazo. Por ende, esta infección afecta a la morbilidad y mortalidad del país.

Para las primeras 29 semanas del 2025, se han notificado 1625 casos con una tasa 30,3 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2024 se reportaron 1793 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 9,36% con 168 casos menos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares, sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en las primeras 29 semanas del año, se reportaron en los hombres un 57,9% de los casos (942/1625), con una tasa de 35,0 por 100 000 habitantes, las mujeres presentan el 42,0% de los casos (683/1625), con una tasa de 25,7 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporto son, 20 a 64 años con 80,98% (1316/1625), seguidos por el de mayores de 65 años con 9,4% con (153/1625), luego por el grupo de 15 a 19 años con 4,6% con (75/1625), y los menores de 1 año con el 4,8% de los casos (78/1625), los menores de 10 a 14 años un caso, grupo de 1 a 4 años dos casos y el grupo de 5 a 9 años sin caso, ver cuadro 1.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos de sífilis en todas sus formas, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 29 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	78	115,5
de 1 a 4 años	2	0,7
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	1	0,3
de 15 a 19 años	75	19,8
de 20 a 24 años	205	52,7
de 25 a 29 años	249	58,6
de 30 a 34 años	245	55,1
de 35 a 39 años	182	40,2
de 40 a 44 años	138	33,8
de 45 a 49 años	107	30,8
de 50 a 54 años	69	23,5
de 55 a 59 años	57	20,4
de 60 a 64 años	64	24,5
de 65 a 69 años	49	22,9
de 70 a 74 años	39	25,0
75 años y más	65	30,8
Total	1625	30,30

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad, según provincias.

Cuadro 2.
Costa Rica: Casos notificados de sífilis en todas sus formas según provincias de procedencia. Números absolutos. (Tasa p/100.000 habitantes), en semana 29 del 2025.

Provincias	Nº	Tasa
San José	577	33,6
Alajuela	223	20,4
Cartago	216	38,8
Heredia	131	23,4
Guanacaste	85	20,2
Puntarenas	127	24,1
Limón	266	55,0
Total	1625	30,30

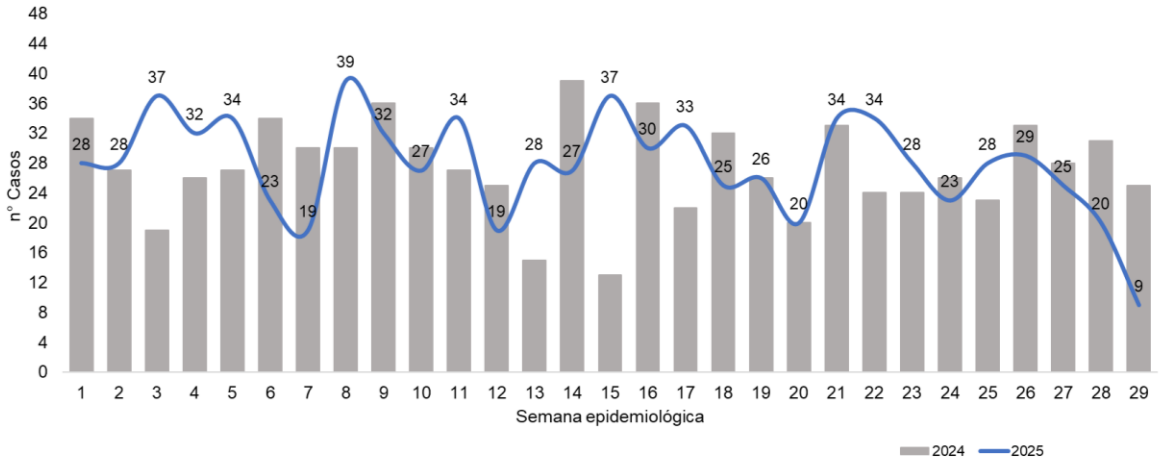
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, la cual es totalmente prevenible con el uso el condón y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales y de la madre al bebé. Por ende, esta enfermedad afecta a la morbilidad y mortalidad del país.

Durante las primeras 29 semanas del 2025, se han notificado 808 casos con una tasa de 15,1 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 795 casos, lo que representa para el año 2025 un ascenso del 1,63 % con 13 casos más. En el gráfico 2, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de esta enfermedad en las primeras 29 semanas del 2025, se reporta en los hombres un 84,0% de los casos (679/808), con una tasa de 25,2 por 100 000 habitantes. En las mujeres con el 15,9% de los casos (129/808), con una tasa de 4,8 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 82,4% (666/808), seguidos por el grupo de 15 a 19 año con 14,6% (118/808), y los mayores de 65 años con 2,0% (16/808), los menores de 1 año dos casos y los de 1 a 14 años con seis casos, ver cuadro 3.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 29 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	2	3,0
1 a 4	2	0,7
5 a 9	1	0,3
10 a 14	3	0,8
15 a 19	118	31,1
20 a 24	202	52,0
25 a 29	151	35,5
30 a 34	120	27,0
35 a 39	79	17,5
40 a 44	44	10,8
45 a 49	18	5,2
50 a 54	24	8,2
55 a 59	19	6,8
60 a 64	9	3,4
65 a 69	10	4,7
70 a 74	3	1,9
Más 75 años	3	1,4
Total	808	15,10

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 4, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 29 del 2025.

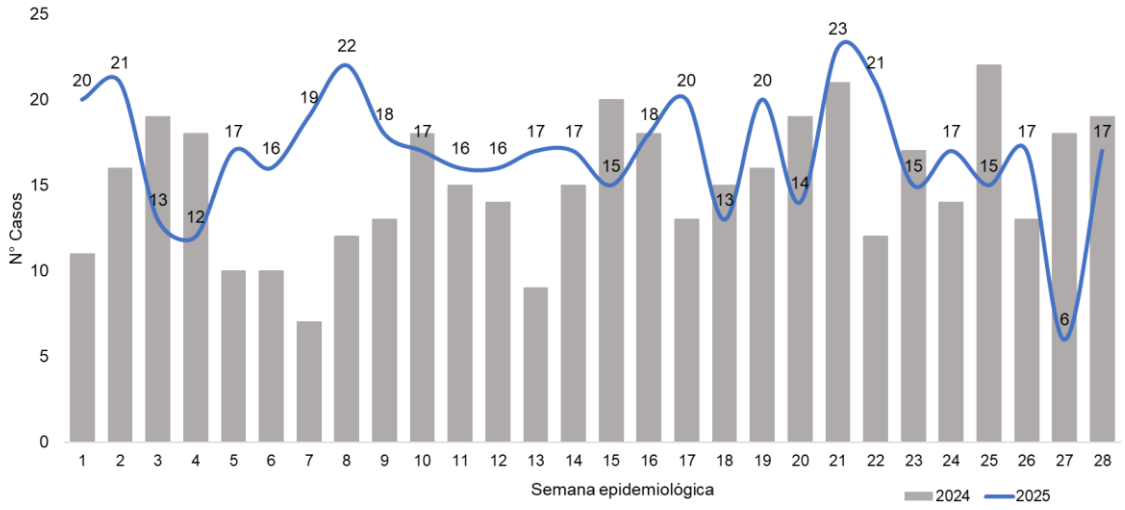
Provincias	Casos	Tasa
San José	294	17,1
Alajuela	110	10,1
Cartago	69	12,4
Heredia	73	13,1
Guanacaste	51	12,1
Puntarenas	93	17,6
Limón	118	24,4
Total	808	15,10

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus Herpes

El virus del herpes es otra de las Infección de transmisión sexual, que se ha reportado en las primeras 29 semanas del año en curso, con 486 casos con una tasa de 9,10 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 437 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 11,0%, con 49 casos más que el periodo anterior. En el gráfico 3, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del virus del herpes en las primeras 29 semanas del año se ha notificado en mujeres un 68,7% de los casos (334/486), con una tasa de 12,5 por 100 000 habitantes, en hombres se reportó el 31,3% de los casos con (152/486), con una tasa de 5,6 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad y los que reportan más son, 20 a 64 años con 82,5% (401/486), seguidos por 15 a 19 años con 12,75% (62/486), mayores de 65 años con 3,8% con (18/486), los menores de 1 año reportan un caso y el de 10 a 14 años con cuatro casos, los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 5.

Cuadro 5.
Costa Rica: Casos de virus del herpes, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 29 del 2025.

Grupos de edad	Caso	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	4	1,1
15 a 19	62	16,3
20 a 24	90	23,2
25 a 29	75	17,6
30 a 34	66	14,9
35 a 39	60	13,3
40 a 44	34	8,3
45 a 49	30	8,6
50 a 54	11	3,7
55 a 59	18	6,5
60 a 64	17	6,5
65 a 69	11	5,1
70 a 74	6	3,9
Más 75 años	1	0,5
Total	486	9,10

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 29 del 2025.

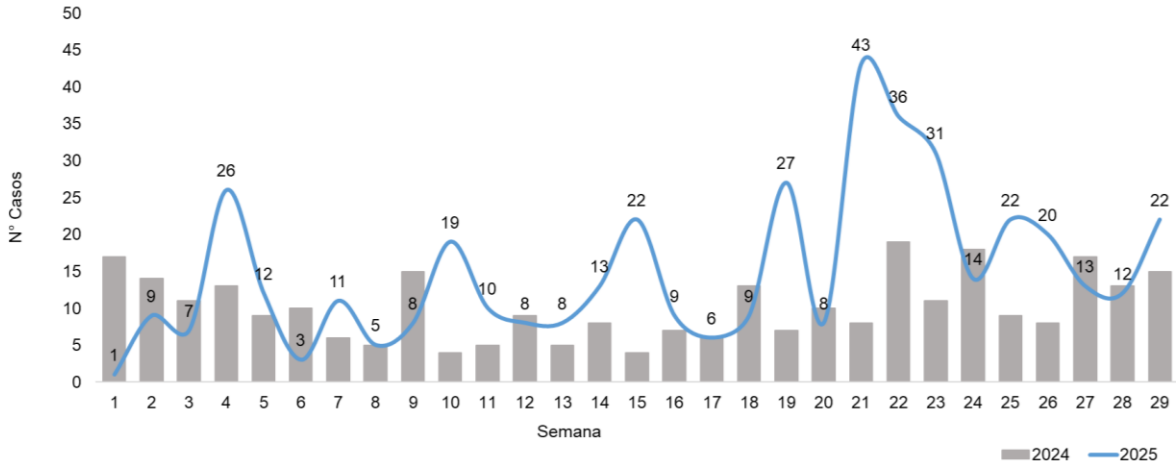
Provincias	Casos	Tasa
San José	235	13,7
Alajuela	48	4,4
Cartago	33	5,9
Heredia	35	6,3
Guanacaste	14	3,3
Puntarenas	61	11,6
Limón	60	12,4
Total	486	9,10

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Es una de Infección que se trasmite por contacto de la piel o por relaciones sexuales sin protección, se puede prevenir con el uso de condones y no tener relaciones sexuales cuando la pareja tiene síntomas. En las primeras 29 semanas del 2025, se notificaron 434 casos con una tasa de 8,4 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 296 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 46,62%, con 138 casos más que el periodo anterior ver gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del VPH en las primeras 29 semanas del año, según sexo se notificaron en las mujeres un 91,2% (396/434), con una tasa de 15,2 por 100 000 habitantes, en los hombres se reportó el 8,76% (38/434), con una tasa de 1,5 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 96,3% (418/434), seguidos por 15 a 19 años con 2,8% (12/434), los mayores 65 años con tres casos, los menores 1 año un caso y los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 7.

Cuadro 7.
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humanos, por grupos de edad. Número absoluto. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 29 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	1	2,0
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	0	0,0
de 15 a 19 años	12	3,2
de 20 a 24 años	29	7,5
de 25 a 29 años	25	6,0
de 30 a 34 años	78	17,9
de 35 a 39 años	90	20,4
de 40 a 44 años	53	13,4
de 45 a 49 años	47	14,2
de 50 a 54 años	26	9,1
de 55 a 59 años	44	15,7
de 60 a 64 años	26	9,9
de 65 a 69 años	3	1,4
de 70 a 74 años	0	0,0
75 años y más	0	0,0
Total	434	8,40

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el siguiente cuadro se presenta la notificación del VPH, según provincia.

Cuadro 8.
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humano, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 29 del 2025.

Provincias	Nº	Tasa
San José	104	6,3
Alajuela	34	3,2
Cartago	15	2,8
Heredia	7	1,3
Guanacaste	110	26,6
Puntarenas	160	31,6
Limón	4	0,9
Total	434	8,40

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Miasis por gusano barrenador en humanos

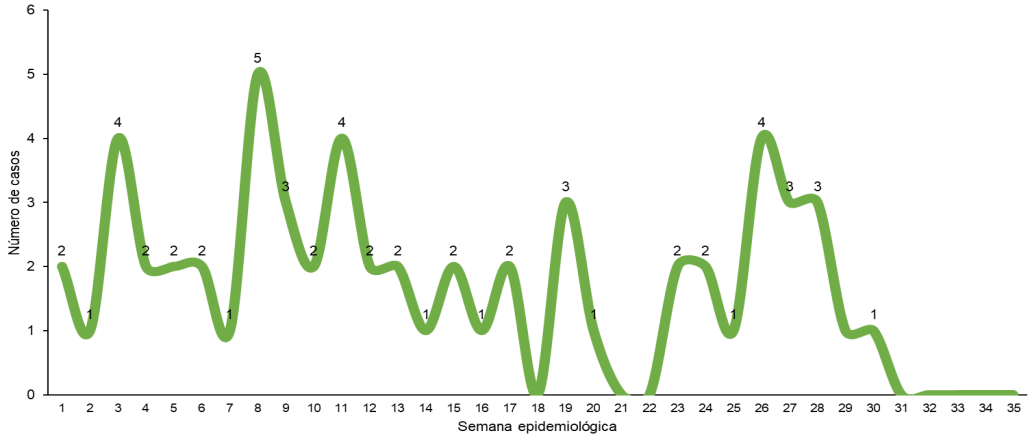
María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 30 del año 2025, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.
En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2025 a la SE 30, se tienen los siguientes datos:

- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 59 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (27/59) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (28/59).

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 30, 2025.



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

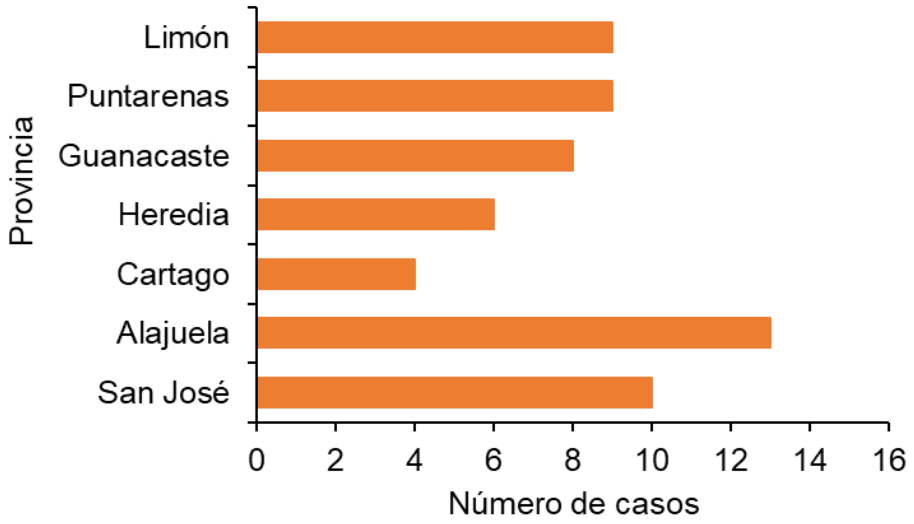
Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasa (tasa p/100.000 habitantes) según grupo de edad, de la SE 01 a la 30, 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
TOTAL	**59**	**1,1**
< 1	0	0,0
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	3	0,8
15 a 19	1	0,3
20 a 24	3	0,8
25 a 29	3	0,7
30 a 34	1	0,2
35 a 39	1	0,2
40 a 44	3	0,7
45 a 49	5	1,4
50 a 54	1	0,3
55 a 59	3	1,1
60 a 64	7	2,7
65 a 69	5	2,3
70 a 74	4	2,6
≥75	18	8,5

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2025, presenta un predominio en los hombres con 38 casos notificados con una tasa de 1,4 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 21 casos notificados con una tasa de 0,8 por 100.000 habitantes.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según provincia de procedencia, de la SE 01 a 30, 2025.



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por número de casos notificados a la SE 30 según provincia de procedencia, presentando mayor número de casos la provincia de Alajuela (13/59) seguido por la provincia de San José (10/59).

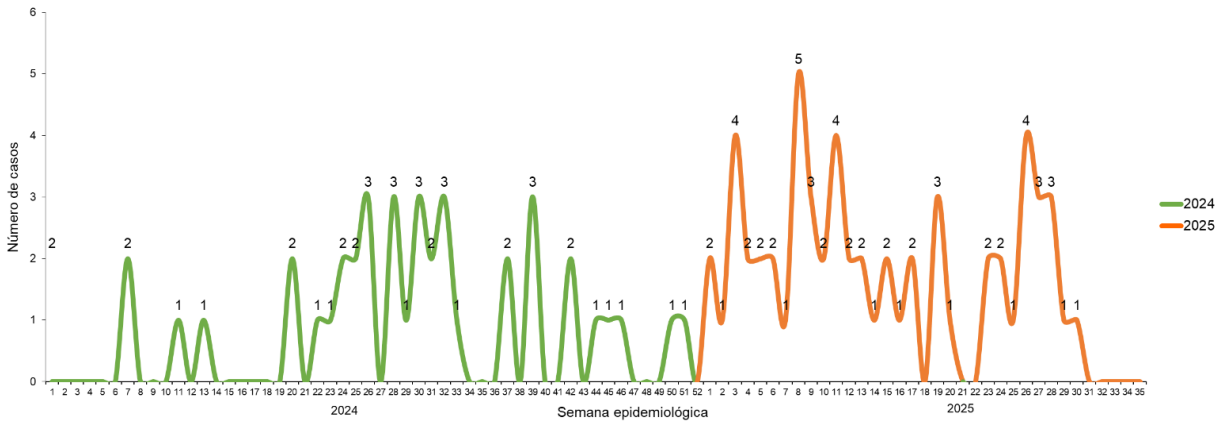
Cuadro 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasa (tasa p/100.000 habitantes) según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a la 30, 2025.

Regiones	Casos	Tasa
Total	**59**	**1,1**
Central Norte	10	0,9
Central Sur	9	0,6
Huetar Caribe	9	1,9
Chorotega	8	1,7
Central Occidente	6	2,6
Brunca	6	1,6
Pacifico Central	5	1,5
Central Este	4	0,7
Huetar Norte	2	0,7

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del Ministerio de Salud, siendo la región Central Norte (10/58) la que presenta el mayor número de casos notificados.

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 52 del 2024 al corte de la SE 30 del 2025.

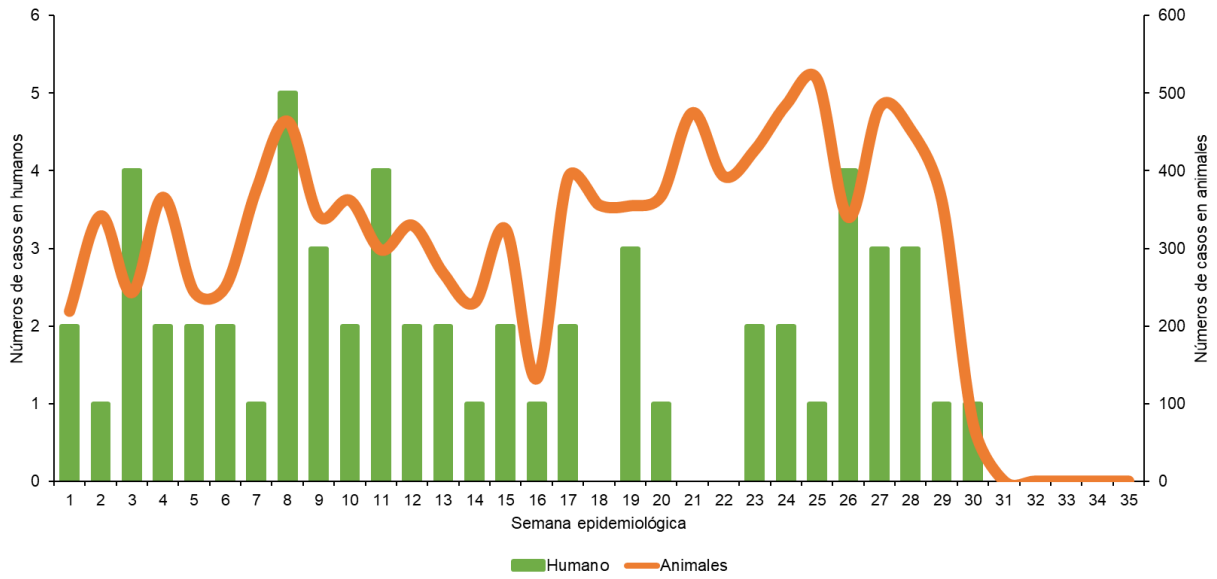


Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

En el gráfico 3 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 52 del 2024 y SE 01 a 30 del 2025, observando un aumento significativo de los casos durante la SE 08 del 2025, con un total de 59 casos confirmados por esta enfermedad en el país.

Dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*), es de suma importancia que ante la identificación de un caso sospechoso en humanos se realice el abordaje bajo el enfoque de **Una Sola Salud**, mediante coordinación interinstitucional Ministerio de Salud-Ministerio de Agricultura y Ganadería-Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)-Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) según corresponda, para identificar casos sospechosos en humanos y/o animales y puedan ser atendidos de manera oportuna.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador en humanos y animales según SE de la 01 a la 30, 2025.



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Boletín Epidemiológico Extraordinario Gusano Barrenador actualizado al 26 de julio del 2025, SENASA / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 4, se muestran los casos de miasis por gusano barrenador en humanos y animales por SE de la 01 a la 30 del 2025, con 59 casos confirmados en humanos y 10271 casos confirmados en animales (datos preliminares en animales sujetos a cambio).

A continuación, se brinda algunas generalidades de prevención y control de esta enfermedad:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA-MINAE) sobre la aparición de animales con gusaneras para que reciban atención oportuna